



Santos: o poder local vivido em toda sua intensidade

As transformações de Santos, no litoral paulista, marcaram um novo paradigma na saúde pública: emblemático, como marca o início do processo de municipalização da saúde; na saúde mental, o marco da intervenção é o fechamento do Hospital Psiquiátrico Anchieta, em 1989, e a invenção dos novos serviços em rede. Pela extensão e radicalidade dessa experiência, ainda mais pensando em um atendimento à crise substitutivo ao modelo hospitalar, como apontam Amarante e Torre (2018), é importante contarmos um pouco mais dessa história.

Em 1989, a intervenção na Casa de Saúde Anchieta revelou um cenário de abandono e tortura, depois de denúncias referentes a três mortes acontecidas. Em vez de simplesmente reformar o hospital, a equipe liderada por Telma de Souza, prefeita, e David Capistrano Filho, então Secretário de Saúde, decidiu fechá-lo e apostar em novas propostas. A intervenção foi um ato de abertura para o mundo e criou um fato político com a presença da imprensa e em articulação ampla com sindicatos, organizações da sociedade civil, comissão de direitos humanos da OAB, conselhos comunitários de saúde, entre outros.

É importante lembrar que o município não apenas interveio em um hospital por causa de denúncias de maus-tratos, o que era até relativamente comum, mas atuou com responsabilidade sanitária, mesmo dentro de um estabelecimento privado, e assumiu a direção administrativa de um ente privado. Levaram a sério a constituição de 1988, em que a municipalização da saúde foi estabelecida, poucos meses depois de promulgada (Kinoshita, 2009).

A intervenção no Anchieta realizou, ao mesmo tempo, a desmontagem de um manicômio e a invenção dos novos serviços e práticas pelos bairros e questionamento do mandato social dos profissionais. Os relatos de quem participou da intervenção trazem o horror do descaso dentro do hospital, mas dizem também de período de abertura alegre e vigoroso em que trabalhadores, usuários, comunidade e gestão criaram formas de viver no mundo com e entre pessoas com risco grande de institucionalização em manicômios, presídios, abrigos, ou pelas disciplinas e categorizações profissionais.

Enquanto o processo de fechamento se desenrolava, no lugar, criaram-se ao mesmo tempo os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) – os primeiros serviços 24h, abertos à cidade e às crises, e conectados à rede de saúde e cultura. Nos NAPS, a crise deixa de ser motivo para internação e passa a ser uma das portas de entrada para o cuidado. A pessoa em situação de crise não era mais isolada, mas acolhida em seu território. A equipe incentivava o questionamento do poder de exclusão dos profissionais da saúde, buscava consensos e sustentava o dissenso com



os usuários, promovendo assembleias, reuniões e decisões tomadas coletivamente de maneira insistente.

Essa forma coletiva de pensar as instituições e o cuidado é uma das qualidades da experiência, bem descrita por Florianita Braga-Campos (2020): “Santos foi uma cidade que viveu intensamente o poder local”. Os conselhos de saúde, habitação, educação, assistência social, as conferências, pré-conferências e assembleias, a capitalização da municipalização da saúde ocorreram fomentando esse poder local, buscando com que os habitantes de Santos pudessem exercer sua cidadania em seus diversos âmbitos. Inclusive os considerados loucos, antes marginalizados e despídos de vida social, estavam presentes pensando a própria vida em comunidade.

Foi preciso pensar nas condições de vida da pessoa e não só na doença, pois, como afirma Braga-Campos (2020), “tratar exclusivamente a doença, naquelas situações, só contribuía para manter a exclusão, a violência, a negação do outro”. Em vez disso, o tratamento acontecia na vida, produzindo mais vida, e não fora dela. Ora, se o poder local é um norte no cuidado, é preciso repensar a prática. A pergunta é: como viver a cidade e na cidade, e como possibilitar que um louco, ex-interno de Hospital Psiquiátrico, participe de uma assembleia, de um conselho local, de uma reunião na assembleia legislativa, do churrasco em família, da festa junina da igreja do bairro ou da atividade da UBS?

O NAPS não se propunha a ser um espaço de exclusão diferente do mundo externo, mas se propunha estar no mundo lidando com as diferenças e complexidades desse mesmo mundo. Propunha-se escutar o sofrimento que precisa ser reconhecido, sustentando o lugar de cidadão para aquele considerado louco e sem direitos.